

# Accouchement inopiné

## L'accouchement n'a pas encore eu lieu

- installer la femme enceinte sur le côté<sup>1</sup> ;
- réaliser un bilan de la femme enceinte, et au cours du 4ème regard, recueillir<sup>2</sup> les éléments suivants :
  - la date et le lieu prévus de l'accouchement ;
  - **les contractions** : heure du début (douleurs régulières), durée et intervalle entre deux ;
  - **la perte des eaux** : heure de la perte et couleur du liquide (transparent, trouble, sanglant) ;
  - si la parturiente a perdu du sang ;
  - si la parturiente sent le bébé bouger ;
  - le suivi ou non de la grossesse ;
  - les problèmes liés à cette grossesse (malformation fœtale, diabète, hypertension, œdèmes, etc.) ;
  - s'il s'agit d'une grossesse simple ou multiple et son déroulement ;
  - le type d'accouchement prévu (voie basse ou césarienne) et nature de la présentation (tête, siège, épaule),
  - le nombre d'accouchements déjà réalisé et leur déroulement.
- demander un avis médical en transmettant le bilan.

## Si le transport de la femme enceinte peut être réalisé

- relever et installer la victime sur un brancard, allongée sur le côté<sup>1</sup> et ceinturée ;
- transporter la victime en milieu hospitalier ;
- surveiller la victime durant le transport.

## Si le transport de la femme enceinte ne peut pas être réalisé, après avis médical, l'accouchement doit être réalisé sur place

- se protéger contre le risque de projection de liquides (gants, masque, lunettes de protection) ;
- préparer le matériel nécessaire à l'accouchement et à l'accueil du nouveau-né :
  - serviettes de bain propres et sèches ;
  - récipient pour recueillir les liquides corporels et le placenta ;
  - le matériel nécessaire à une éventuelle réanimation du nouveau-né :
    - bouteille d'oxygène, insufflateur manuel pédiatrique ;
    - aspirateur de mucosités avec une sonde adaptée au nouveau-né ;
    - oxymètre de pouls.
- installer la parturiente dans la position qui lui convient le mieux (demi-assise<sup>3</sup>, sur le côté, bord du lit, etc.) ;
- réaliser l'accouchement. Pour cela :
  - demander à la parturiente de pousser :
    - à partir du moment où le haut du crâne du nouveau-né commence à apparaître à la vulve ;
    - lorsqu'elle ressent un besoin irrésistible de pousser.

<sup>1</sup> De préférence sur le côté gauche. L'installation sur le dos est à proscrire.

<sup>2</sup> En questionnant la femme enceinte ou son entourage, ou en consultant le carnet de maternité.

<sup>3</sup> En cas de position demi-assise, il est préférable que la mère ait les fesses légèrement au-delà du bord du lit ou du brancard, avec les cuisses fléchies, de façon que le bassin soit partiellement dans le vide.

- lui demander de pousser vers le bas en retenant sa respiration dès qu'elle ressent la contraction et, si possible, jusqu'au maximum de la contraction ;
- en cas de position demi-assise, lui demander d'attraper ses cuisses avec ses mains et d'hyper-fléchir ses cuisses sur l'abdomen pendant la poussée ;
- faire reposer les jambes à la fin de la contraction utérine ;
- recommencer la même manœuvre jusqu'à l'apparition de la moitié de la tête du nouveau-né ;
- dès lors que la moitié de la tête du nouveau-né est apparu, cesser alors de faire pousser la parturiente, laisser se terminer l'expulsion naturellement tout en ralentissant la sortie de la tête en la maintenant d'une main afin d'éviter les déchirures du périnée ;
- accompagner progressivement la sortie spontanée du nouveau-né. Pour cela :
  - lâcher la tête du nouveau-né pour ne pas s'opposer à sa rotation<sup>1</sup>,
  - une fois la tête totalement sortie, si la tête ne tourne pas, demander à la parturiente d'arrêter de pousser et vérifier s'il y a un circulaire du cordon autour du cou du nouveau-né,
  - en présence d'un circulaire du cordon, procéder à son dégagement,
  - maintenir la tête de l'enfant le temps du dégagement des épaules qui sortent l'une (épaule antérieure) après l'autre (épaule postérieure) ;
  - soutenir le corps du nouveau-né avec les mains placées sous lui au cours de sa sortie,
  - le nouveau-né, recouvert de liquide amniotique et du sang de la mère, est particulièrement glissant et doit être maintenu fermement. Ne jamais tirer sur l'enfant.
- noter l'heure de naissance ;
- assurer la prise en charge du nouveau-né ;
- surveiller la mère jusqu'à la délivrance.

## L'accouchement est déjà réalisé

- réaliser simultanément un bilan complet de la mère et du nouveau-né ;
- demander l'heure de la naissance ;
- demander un avis médical en transmettant les deux bilans et appliquer les consignes reçues ;
- prendre en charge le nouveau-né.

En l'absence d'équipe médicale, surveiller la mère et l'assister pendant la délivrance.

## La délivrance

La délivrance se fait chez une femme après l'accouchement et le plus souvent en présence d'une équipe médicale. Toutefois, en son absence, il faut réaliser les actions suivantes :

- laisser sortir le placenta sans tirer dessus, ni sur le cordon ombilical et en faisant pousser ;
- recueillir le placenta, dans une cuvette ou un sac plastique, une fois expulsé ;
- l'acheminer avec la mère à l'hôpital pour vérifier son intégrité ;
- réaliser un massage utérin pour prévenir les hémorragies après la naissance ;
- placer un pansement absorbant ;
- surveiller la mère ;
- s'assurer de l'absence d'hémorragie extériorisée<sup>2</sup>.

**Cas particulier : si le placenta ne sort pas au bout de 30 minutes après la naissance, réaliser un massage utérin pour prévenir une hémorragie.**

<sup>1</sup> Généralement la tête regarde vers le bas puis effectue une rotation d'un quart de tour sur la droite ou la gauche au cours de sa sortie

<sup>2</sup> Une hémorragie secondaire peut survenir après la délivrance. En présence de celle-ci, appliquer la conduite à tenir adaptée.